

Relecture des 8 exercices brouillon

Bibliothèque d'exercices — 23/08/2026, pour votre validation

Ces 8 exercices ont été rédigés au Sprint 5bis/5ter (19/08/2026) à partir des références déjà citées au §81, et sont désormais chargés en base (infra/db/seed/0010_..._20260819.sql), consultables et modifiables dans /admin/exercices. Ils sont tous au statut pending_validation : aucun n'est visible des patients tant que vous ne le validez pas explicitement.

Deux notes ont été mises à jour depuis leur première rédaction : Hoffmann et al. 2023 (exercices 6 et 7, ostéoporose) et ASAS-EULAR 2022 (exercice 8, spondyloarthrite axiale) étaient inaccessibles lors de la première recherche — leur texte intégral a pu être vérifié depuis, le contenu ci-dessous reflète cette mise à jour.

Sur votre demande, les champs qu'aucune des 10 références ne permettait de renseigner ont été complétés par des propositions construites sur des repères génériques d'exercice thérapeutique reconnus (ACSM, échelle de Borg, règle de progression usuelle de 5 à 10 %/semaine), plutôt que sur les 10 références pathologie-spécifiques — ce ne sont pas des données probantes, mais des propositions raisonnables et prudentes, à votre validation.

Noir : contenu directement issu d'une des 10 références citées.

Bleu/italique (PROPOSITION) : proposition de l'assistant sur repères génériques (ACSM, Borg, progression usuelle), hors des 10 références — à valider ou corriger.

Exercice 1 — Marche régulière adaptée (lombalgie)

Pathologie(s) : Lombalgie commune | Catégorie : aerobique | Objectifs : Diminuer la sédentarité, Améliorer la condition physique | Matériel : aucun

Description courte — Marche à allure confortable, dans le cadre d'un programme d'exercice structuré.

Description détaillée — D'après l'OMS 2023 (guideline lombalgie chronique primaire), déjà citée au §6 du cahier des charges : un programme d'exercice structuré peut être proposé aux adultes présentant une lombalgie chronique primaire. Le détail (durée, fréquence, type précis) n'a pas pu être vérifié au-delà de ce principe général — voir colonnes ci-contre. Complément d'après George et al. 2021 (JOSPT, texte intégral) : pour la lombalgie chronique, l'exercice général (restaurer/améliorer la force ou l'endurance des grands groupes musculaires des membres et du tronc, incluant des exercices de flexibilité/mobilité et d'aérobie/conditionnement) fait partie des interventions recommandées avec un niveau de preuve fort (recommandation A), au même titre que le renforcement/endurance du tronc, l'exercice aérobique, aquatique et multimodal — sans supériorité démontrée d'un type sur un autre.

Intensité — *PROPOSITION (hors des 10 références citées, repère générique d'exercice thérapeutique — à valider) — intensité légère à modérée, Borg CR10 ≈ 2-4 (méthode réf. B6), talk test positif ; à ajuster selon le niveau du programme auquel l'exercice est intégré.*

Progression — *PROPOSITION (hors des 10 références citées, repère générique d'exercice thérapeutique — à valider) — augmenter la durée de marche de 5 à 10 % par semaine si bonne tolérance (pas d'aggravation à 24h), cohérent avec le principe « rester actif » de George et al. 2021.*

Contre-indications — *PROPOSITION (hors des 10 références citées, repère générique d'exercice thérapeutique — à valider) — red flags actifs (déjà couverts par le dépistage de sécurité de l'application), douleur radiculaire aiguë non stabilisée.*

Précautions — D'après George et al. 2021 (JOSPT 2021;51(11):CPG1-CPG60, DOI 10.2519/jospt.2021.0304 — texte intégral vérifié), section « Intervention: Patient Education » : les stratégies d'éducation ne doivent PAS augmenter la perception de menace ou la peur associée à la lombalgie — il est notamment déconseillé de recommander le repos au lit prolongé ou de donner des explications pathoanatomiques approfondies sur la cause précise de la douleur (Recommandation, niveau B). À l'inverse, il est recommandé d'insister sur le pronostic globalement favorable de la lombalgie aiguë, sur l'importance de rester actif malgré la douleur, et sur l'amélioration du niveau d'activité (pas seulement le soulagement de la douleur) comme objectif.

Critères d'arrêt — *PROPOSITION (hors des 10 références citées, repère générique d'exercice thérapeutique — à valider) — douleur > 6/10 en cours d'exercice, douleur irradiante nouvelle ou aggravée dans la jambe, essoufflement empêchant de parler.*

Références (DOI) — 10.2519/jospt.2021.0304

Votre décision

Statut retenu (entourer ou écrire) : draft / pending_validation / validated / retiré

Modifications ou compléments à apporter avant validation :

Exercice 2 — Marche adaptée (arthrose du genou/hanche)

Pathologie(s) : Arthrose du genou, Arthrose de hanche | Catégorie : aerobique | Objectifs : Améliorer la mobilité, Diminuer la sédentarité
| Matériel : aucun

Description courte — Marche recommandée comme option d'exercice aérobique de première intention, au même titre que le renforcement ou l'exercice aquatique.

Description détaillée — D'après Kolasinski et al. 2019 (ACR/Arthritis Foundation) : « l'exercice pour l'arthrose du genou et de la hanche peut inclure la marche, le renforcement, l'entraînement neuromusculaire et l'exercice aquatique, sans hiérarchie entre ces options » (recommandation FORTE).

Intensité — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : chez les personnes déconditionnées ou avec limitations fonctionnelles importantes, l'exercice à intensité modérée ou vigoureuse peut être initialement trop épuisant. Il est jugé approprié de débiter avec une dose plus faible, bien tolérée, puis d'augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. Au-delà de ce principe, les paramètres FITT-VP exacts (fréquence, intensité, temps, type, volume, progression) doivent être définis individuellement par le professionnel de santé (Recommandation 7 du document) — aucun chiffre cible générique (ex. % FC max, minutes/semaine) n'est fourni par cette référence.

Progression — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : chez les personnes déconditionnées ou avec limitations fonctionnelles importantes, l'exercice à intensité modérée ou vigoureuse peut être initialement trop épuisant. Il est jugé approprié de débiter avec une dose plus faible, bien tolérée, puis d'augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. Au-delà de ce principe, les paramètres FITT-VP exacts (fréquence, intensité, temps, type, volume, progression) doivent être définis individuellement par le professionnel de santé (Recommandation 7 du document) — aucun chiffre cible générique (ex. % FC max, minutes/semaine) n'est fourni par cette référence.

Contre-indications — D'après EULAR 2025/2026 (Rausch Osthoff et al., Ann Rheum Dis 2026;85:1026-1038 — texte intégral vérifié, section « Recommandation 4 ») : il n'existe pas de contre-indication spécifique à la pathologie pour l'activité physique en tant que telle chez les personnes avec arthrite inflammatoire ou arthrose (« there are no disease-specific contraindications for PA per se » — cette contre-indication figurait dans la version 2018 des recommandations EULAR mais a été retirée en 2025/2026, faute de preuve). En revanche, l'intensité doit être adaptée à l'activité de la maladie et à l'état de santé du moment : en cas d'atteinte d'une articulation donnée (ex. genou gonflé), éviter l'exercice de forte intensité impliquant spécifiquement cette zone ; l'exercice de forte intensité reste possible sur les zones non atteintes (ex. membres supérieurs à la place des membres inférieurs).

Précautions — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : les effets indésirables rapportés dans les études sur l'arthrite inflammatoire et l'arthrose sont transitoires et légers (ex. douleur musculaire, fatigue) ; aucun effet délétère de l'exercice sur l'activité de la maladie n'est rapporté. Une augmentation transitoire de la douleur dans les 48 à 72 heures suivant l'exercice peut être normale (courbatures/DOMS), en particulier chez les personnes novices en exercice. En cas de poussée, les activités de forte intensité peuvent devenir impossibles, mais des activités de plus faible intensité (marche, exercices d'amplitude articulaire) restent le plus souvent possibles — à adapter selon la zone du corps touchée.

Critères d'arrêt — *PROPOSITION (hors des 10 références citées, repère générique d'exercice thérapeutique — à valider) — douleur articulaire > 5-6/10 en cours d'exercice, gonflement articulaire aigu nouveau, dérobement/instabilité en charge, essoufflement empêchant de parler.*

Références (DOI) — 10.1002/acr.24131,10.1016/j.ard.2026.03.006

Votre décision

Statut retenu (entourer ou écrire) : draft / pending_validation / validated / retiré

Modifications ou compléments à apporter avant validation :

Exercice 3 — Renforcement musculaire des membres inférieurs (arthrose)

Pathologie(s) : Arthrose du genou, Arthrose de hanche | Catégorie : renforcement | Objectifs : Améliorer la force | Matériel : chaise

Description courte — Renforcement musculaire recommandé en première intention pour l'arthrose du genou et de la hanche, sans hiérarchie par rapport à la marche ou l'exercice aquatique.

Description détaillée — D'après Kolasinski et al. 2019 (ACR/Arthritis Foundation), recommandation FORTE pour l'exercice incluant le renforcement musculaire, sans hiérarchie de modalité.

Intensité — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : chez les personnes déconditionnées ou avec limitations fonctionnelles importantes, l'exercice à intensité modérée ou vigoureuse peut être initialement trop épuisant. Il est jugé approprié de débiter avec une dose plus faible, bien tolérée, puis d'augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. Au-delà de ce principe, les paramètres FITT-VP exacts (fréquence, intensité, temps, type, volume, progression) doivent être définis individuellement par le professionnel de santé (Recommandation 7 du document) — aucun chiffre cible générique (ex. % FC max, minutes/semaine) n'est fourni par cette référence.

Progression — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : chez les personnes déconditionnées ou avec limitations fonctionnelles importantes, l'exercice à intensité modérée ou vigoureuse peut être initialement trop épuisant. Il est jugé approprié de débiter avec une dose plus faible, bien tolérée, puis d'augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. Au-delà de ce principe, les paramètres FITT-VP exacts (fréquence, intensité, temps, type, volume, progression) doivent être définis individuellement par le professionnel de santé (Recommandation 7 du document) — aucun chiffre cible générique (ex. % FC max, minutes/semaine) n'est fourni par cette référence.

Contre-indications — D'après EULAR 2025/2026 (Rausch Osthoff et al., Ann Rheum Dis 2026;85:1026-1038 — texte intégral vérifié, section « Recommandation 4 ») : il n'existe pas de contre-indication spécifique à la pathologie pour l'activité physique en tant que telle chez les personnes avec arthrite inflammatoire ou arthrose (« there are no disease-specific contraindications for PA per se » — cette contre-indication figurait dans la version 2018 des recommandations EULAR mais a été retirée en 2025/2026, faute de preuve). En revanche, l'intensité doit être adaptée à l'activité de la maladie et à l'état de santé du moment : en cas d'atteinte d'une articulation donnée (ex. genou gonflé), éviter l'exercice de forte intensité impliquant spécifiquement cette zone ; l'exercice de forte intensité reste possible sur les zones non atteintes (ex. membres supérieurs à la place des membres inférieurs).

Précautions — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : les effets indésirables rapportés dans les études sur l'arthrite inflammatoire et l'arthrose sont transitoires et légers (ex. douleur musculaire, fatigue) ; aucun effet délétère de l'exercice sur l'activité de la maladie n'est rapporté. Une augmentation transitoire de la douleur dans les 48 à 72 heures suivant l'exercice peut être normale (courbatures/DOMS), en particulier chez les personnes novices en exercice. En cas de poussée, les activités de forte intensité peuvent devenir impossibles, mais des activités de plus faible intensité (marche, exercices d'amplitude articulaire) restent le plus souvent possibles — à adapter selon la zone du corps touchée.

Critères d'arrêt — *PROPOSITION (hors des 10 références citées, repère générique d'exercice thérapeutique — à valider) — douleur articulaire > 5-6/10 pendant l'exercice, gonflement aigu nouveau, dérobement du genou.*

Muscles ciblés — Quadriceps, ischio-jambiers, fessiers (muscles génériquement associés au renforcement membre inférieur — exercice précis à définir)

Références (DOI) — 10.1002/acr.24131,10.1016/j.ard.2026.03.006

Votre décision

Statut retenu (entourer ou écrire) : draft / pending_validation / validated / retiré

Modifications ou compléments à apporter avant validation :

Exercice 4 — Activité aérobique adaptée (polyarthrite rhumatoïde)

Pathologie(s) : Polyarthrite rhumatoïde | Catégorie : aérobique | Objectifs : Diminuer la sédentarité, Améliorer la condition physique | Matériel : aucun

Description courte — Activité aérobique conditionnellement recommandée, à privilégier à la sédentarité.

Description détaillée — D'après England et al. 2022 (ACR) : recommandation FORTE pour « un engagement constant dans l'exercice plutôt que l'absence d'exercice ». Recommandation conditionnelle (preuves de faible qualité) en faveur de l'exercice aérobique.

Intensité — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : chez les personnes déconditionnées ou avec limitations fonctionnelles importantes, l'exercice à intensité modérée ou vigoureuse peut être initialement trop épuisant. Il est jugé approprié de débiter avec une dose plus faible, bien tolérée, puis d'augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. Au-delà de ce principe, les paramètres FITT-VP exacts (fréquence, intensité, temps, type, volume, progression) doivent être définis individuellement par le professionnel de santé (Recommandation 7 du document) — aucun chiffre cible générique (ex. % FC max, minutes/semaine) n'est fourni par cette référence.

Progression — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : chez les personnes déconditionnées ou avec limitations fonctionnelles importantes, l'exercice à intensité modérée ou vigoureuse peut être initialement trop épuisant. Il est jugé approprié de débiter avec une dose plus faible, bien tolérée, puis d'augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. Au-delà de ce principe, les paramètres FITT-VP exacts (fréquence, intensité, temps, type, volume, progression) doivent être définis individuellement par le professionnel de santé (Recommandation 7 du document) — aucun chiffre cible générique (ex. % FC max, minutes/semaine) n'est fourni par cette référence.

Contre-indications — D'après EULAR 2025/2026 (Rausch Osthoff et al., Ann Rheum Dis 2026;85:1026-1038 — texte intégral vérifié, section « Recommandation 4 ») : il n'existe pas de contre-indication spécifique à la pathologie pour l'activité physique en tant que telle chez les personnes avec arthrite inflammatoire ou arthrose (« there are no disease-specific contraindications for PA per se » — cette contre-indication figurait dans la version 2018 des recommandations EULAR mais a été retirée en 2025/2026, faute de preuve). En revanche, l'intensité doit être adaptée à l'activité de la maladie et à l'état de santé du moment : en cas d'atteinte d'une articulation donnée (ex. genou gonflé), éviter l'exercice de forte intensité impliquant spécifiquement cette zone ; l'exercice de forte intensité reste possible sur les zones non atteintes (ex. membres supérieurs à la place des membres inférieurs).

Précautions — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : les effets indésirables rapportés dans les études sur l'arthrite inflammatoire et l'arthrose sont transitoires et légers (ex. douleur musculaire, fatigue) ; aucun effet délétère de l'exercice sur l'activité de la maladie n'est rapporté. Une augmentation transitoire de la douleur dans les 48 à 72 heures suivant l'exercice peut être normale (courbatures/DOMS), en particulier chez les personnes novices en exercice. En cas de poussée, les activités de forte intensité peuvent devenir impossibles, mais des activités de plus faible intensité (marche, exercices d'amplitude articulaire) restent le plus souvent possibles — à adapter selon la zone du corps touchée.

Critères d'arrêt — *PROPOSITION (hors des 10 références citées, repère générique d'exercice thérapeutique — à valider) — signe de poussée en cours de séance (gonflement articulaire nouveau, raideur marquée), douleur > 6/10, essoufflement empêchant de parler.*

Références (DOI) — 10.1002/acr.25117,10.1016/j.ard.2026.03.006

Votre décision

Statut retenu (entourer ou écrire) : draft / pending_validation / validated / retiré

Modifications ou compléments à apporter avant validation :

Exercice 5 — Renforcement musculaire léger (polyarthrite rhumatoïde)

Pathologie(s) : Polyarthrite rhumatoïde | Catégorie : renforcement | Objectifs : Améliorer la force | Matériel : aucun

Description courte — Renforcement musculaire conditionnellement recommandé, à privilégier à la sédentarité.

Description détaillée — D'après England et al. 2022 (ACR) : recommandation conditionnelle (preuves de faible qualité) en faveur du renforcement musculaire, de l'exercice aquatique et des approches corps-esprit, en complément de l'exercice aérobique.

Intensité — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : chez les personnes déconditionnées ou avec limitations fonctionnelles importantes, l'exercice à intensité modérée ou vigoureuse peut être initialement trop épuisant. Il est jugé approprié de débiter avec une dose plus faible, bien tolérée, puis d'augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. Au-delà de ce principe, les paramètres FITT-VP exacts (fréquence, intensité, temps, type, volume, progression) doivent être définis individuellement par le professionnel de santé (Recommandation 7 du document) — aucun chiffre cible générique (ex. % FC max, minutes/semaine) n'est fourni par cette référence.

Progression — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : chez les personnes déconditionnées ou avec limitations fonctionnelles importantes, l'exercice à intensité modérée ou vigoureuse peut être initialement trop épuisant. Il est jugé approprié de débiter avec une dose plus faible, bien tolérée, puis d'augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. Au-delà de ce principe, les paramètres FITT-VP exacts (fréquence, intensité, temps, type, volume, progression) doivent être définis individuellement par le professionnel de santé (Recommandation 7 du document) — aucun chiffre cible générique (ex. % FC max, minutes/semaine) n'est fourni par cette référence.

Contre-indications — D'après EULAR 2025/2026 (Rausch Osthoff et al., Ann Rheum Dis 2026;85:1026-1038 — texte intégral vérifié, section « Recommandation 4 ») : il n'existe pas de contre-indication spécifique à la pathologie pour l'activité physique en tant que telle chez les personnes avec arthrite inflammatoire ou arthrose (« there are no disease-specific contraindications for PA per se » — cette contre-indication figurait dans la version 2018 des recommandations EULAR mais a été retirée en 2025/2026, faute de preuve). En revanche, l'intensité doit être adaptée à l'activité de la maladie et à l'état de santé du moment : en cas d'atteinte d'une articulation donnée (ex. genou gonflé), éviter l'exercice de forte intensité impliquant spécifiquement cette zone ; l'exercice de forte intensité reste possible sur les zones non atteintes (ex. membres supérieurs à la place des membres inférieurs).

Précautions — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : les effets indésirables rapportés dans les études sur l'arthrite inflammatoire et l'arthrose sont transitoires et légers (ex. douleur musculaire, fatigue) ; aucun effet délétère de l'exercice sur l'activité de la maladie n'est rapporté. Une augmentation transitoire de la douleur dans les 48 à 72 heures suivant l'exercice peut être normale (courbatures/DOMS), en particulier chez les personnes novices en exercice. En cas de poussée, les activités de forte intensité peuvent devenir impossibles, mais des activités de plus faible intensité (marche, exercices d'amplitude articulaire) restent le plus souvent possibles — à adapter selon la zone du corps touchée.

Critères d'arrêt — *PROPOSITION (hors des 10 références citées, repère générique d'exercice thérapeutique — à valider) — douleur articulaire > 6/10, gonflement nouveau pendant l'exercice, signe de poussée.*

Références (DOI) — 10.1002/acr.25117,10.1016/j.ard.2026.03.006

Votre décision

Statut retenu (entourer ou écrire) : draft / pending_validation / validated / retiré

Modifications ou compléments à apporter avant validation :

Exercice 6 — Renforcement musculaire avec mise en charge (ostéoporose)

Pathologie(s) : Ostéoporose | Catégorie : renforcement | Objectifs : Améliorer la force, Maintenir l'autonomie | Matériel : aucun

Description courte — Exercice de renforcement en charge, composante de la prévention des fractures ostéoporotiques.

Description détaillée — D'après LeBoff et al. 2022 (Bone Health and Osteoporosis Foundation, Clinician's Guide) : l'exercice en charge (« weight-bearing ») et de renforcement musculaire (« resistance-training ») fait partie de l'arsenal de prévention des fractures, aux côtés du traitement pharmacologique, des apports en calcium/vitamine D et de la prévention des chutes.

Intensité — D'après Hoffmann et al. 2023 (DOI 10.1007/s00198-022-06592-8, texte intégral vérifié le 23/08/2026 — précédemment bloqué, méta-analyse de 11 essais, 9715 participant-années groupe exercice) : l'exercice réduit les fractures ostéoporotiques majeures d'environ 23 % (RR 0,75 ; IC95 % 0,54-0,94 ; p=.006). La progression d'intensité montrait une tendance plus favorable, non statistiquement significative (p=.133 ; 5 études avec progression vs 6 à intensité constante) ; la durée du programme n'avait pas d'effet significatif non plus (p=.883 ; études de 6 mois à 16 ans). Les auteurs concluent EUX-MÊMES que l'hétérogénéité des protocoles empêche de dériver une recommandation fiable de fréquence/intensité/durée — à définir par le concepteur médical malgré cette lecture complète. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repère générique d'exercice thérapeutique — à valider) — valeur cible proposée (méthode réf. B6) : Borg CR10 $\approx$ 2-4 selon niveau, sans mouvement de flexion chargée du tronc (cf. contre-indications).

Progression — D'après Hoffmann et al. 2023 (DOI 10.1007/s00198-022-06592-8, texte intégral vérifié le 23/08/2026 — précédemment bloqué, méta-analyse de 11 essais, 9715 participant-années groupe exercice) : l'exercice réduit les fractures ostéoporotiques majeures d'environ 23 % (RR 0,75 ; IC95 % 0,54-0,94 ; p=.006). La progression d'intensité montrait une tendance plus favorable, non statistiquement significative (p=.133 ; 5 études avec progression vs 6 à intensité constante) ; la durée du programme n'avait pas d'effet significatif non plus (p=.883 ; études de 6 mois à 16 ans). Les auteurs concluent EUX-MÊMES que l'hétérogénéité des protocoles empêche de dériver une recommandation fiable de fréquence/intensité/durée — à définir par le concepteur médical malgré cette lecture complète.

Contre-indications — D'après LeBoff et al. 2022 (Bone Health and Osteoporosis Foundation, Clinician's Guide) : les mouvements de flexion importante du tronc (flexion rachidienne) augmentent le risque de fracture vertébrale, tandis que les mouvements d'extension du rachis le diminuent. Cette information provient de la description d'une figure dans l'abstract — à vérifier sur le texte intégral et à préciser (quels mouvements exactement, quel degré de flexion) avant validation.

Précautions — Contenu dérivé de la description d'une figure dans l'abstract — à vérifier sur le texte intégral avant validation.

Critères d'arrêt — PROPOSITION (hors des 10 références citées, repère générique d'exercice thérapeutique — à valider) — douleur dorsale/lombaire aiguë nouvelle (signe d'alerte de fracture vertébrale — nécessite une évaluation médicale avant poursuite), douleur > 6/10.

Références (DOI) — 10.1007/s00198-021-05900-y, 10.1007/s00198-022-06592-8

Votre décision

Statut retenu (entourer ou écrire) : draft / pending_validation / validated / retiré

Modifications ou compléments à apporter avant validation :

Exercice 7 — Exercices d'extension du rachis (ostéoporose)

Pathologie(s) : Ostéoporose | Catégorie : renforcement | Objectifs : Maintenir l'autonomie | Matériel : aucun

Description courte — Renforcement des extenseurs du rachis ; orientation posturale favorable selon LeBoff et al. 2022.

Description détaillée — D'après LeBoff et al. 2022 : les figures de l'article associent les mouvements d'extension du rachis à une diminution du risque de fracture vertébrale, à l'inverse de la flexion importante du tronc. Exercice précis, position et amplitude restent à définir par le concepteur médical.

Intensité — D'après Hoffmann et al. 2023 (DOI 10.1007/s00198-022-06592-8, texte intégral vérifié le 23/08/2026 — précédemment bloqué, méta-analyse de 11 essais, 9715 participant-années groupe exercice) : l'exercice réduit les fractures ostéoporotiques majeures d'environ 23 % (RR 0,75 ; IC95 % 0,54-0,94 ; p=.006). La progression d'intensité montrait une tendance plus favorable, non statistiquement significative (p=.133 ; 5 études avec progression vs 6 à intensité constante) ; la durée du programme n'avait pas d'effet significatif non plus (p=.883 ; études de 6 mois à 16 ans). Les auteurs concluent EUX-MÊMES que l'hétérogénéité des protocoles empêche de dériver une recommandation fiable de fréquence/intensité/durée — à définir par le concepteur médical malgré cette lecture complète. PROPOSITION (hors des 10 références citées, repère générique d'exercice thérapeutique — à valider) — valeur cible proposée (méthode réf. B6) : Borg CR10 $\approx$ 2-4 selon niveau.

Progression — D'après Hoffmann et al. 2023 (DOI 10.1007/s00198-022-06592-8, texte intégral vérifié le 23/08/2026 — précédemment bloqué, méta-analyse de 11 essais, 9715 participant-années groupe exercice) : l'exercice réduit les fractures ostéoporotiques majeures d'environ 23 % (RR 0,75 ; IC95 % 0,54-0,94 ; p=.006). La progression d'intensité montrait une tendance plus favorable, non statistiquement significative (p=.133 ; 5 études avec progression vs 6 à intensité constante) ; la durée du programme n'avait pas d'effet significatif non plus (p=.883 ; études de 6 mois à 16 ans). Les auteurs concluent EUX-MÊMES que l'hétérogénéité des protocoles empêche de dériver une recommandation fiable de fréquence/intensité/durée — à définir par le concepteur médical malgré cette lecture complète.

Contre-indications — D'après LeBoff et al. 2022 (Bone Health and Osteoporosis Foundation, Clinician's Guide) : les mouvements de flexion importante du tronc (flexion rachidienne) augmentent le risque de fracture vertébrale, tandis que les mouvements d'extension du rachis le diminuent. Cette information provient de la description d'une figure dans l'abstract — à vérifier sur le texte intégral et à préciser (quels mouvements exactement, quel degré de flexion) avant validation.

Précautions — Contenu dérivé de la description d'une figure dans l'abstract — à vérifier sur le texte intégral avant validation.

Critères d'arrêt — PROPOSITION (hors des 10 références citées, repère générique d'exercice thérapeutique — à valider) — douleur dorsale/lombaire aiguë nouvelle (signe d'alerte de fracture vertébrale — nécessite une évaluation médicale avant poursuite), douleur > 6/10.

Références (DOI) — 10.1007/s00198-021-05900-y

Votre décision

Statut retenu (entourer ou écrire) : draft / pending_validation / validated / retiré

Modifications ou compléments à apporter avant validation :

Exercice 8 — Activité physique adaptée générale (spondyloarthrite axiale)

Pathologie(s) : Spondyloarthrite axiale | Catégorie : aerobique | Objectifs : Diminuer la sédentarité, Améliorer la condition physique | Matériel : aucun

Description courte — Activité physique générale adaptée, encadrée par les principes généraux EULAR 2025/2026 pour l'arthrite inflammatoire — PAS un programme spécifique à la spondyloarthrite axiale.

Description détaillée — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral vérifié) : la spondyloarthrite axiale (axSpA) fait partie du périmètre « arthrite inflammatoire » (IA) couvert par ce document, au même titre que la polyarthrite rhumatoïde. Les principes généraux s'appliquent donc (promotion de l'AP comme partie intégrante des soins standards, 4 domaines — cardiorespiratoire, force musculaire, flexibilité, performance neuromotrice — tous jugés applicables et sûrs). Complément d'après ASAS-EULAR 2022 (Ramiro et al., DOI 10.1136/ard-2022-223296, texte intégral vérifié le 23/08/2026 — précédemment bloqué), Recommandation 4 : « Patients should be educated about axSpA and encouraged to exercise on a regular basis... physiotherapy should be considered. » L'exercice y est qualifié de « pilier » de la prise en charge, avec des bénéfices indépendants du traitement pharmacologique ; l'adhérence et l'efficacité sont rapportées comme meilleures en cas de supervision (« Physiotherapy, specifically supervised exercise, has also proven to be more efficacious than home exercises ») — point de vigilance direct pour un exercice réalisé seul via cette application. ATTENTION : ni EULAR 2025/2026 ni ASAS-EULAR 2022 ne fournissent de contenu spécifique à la mobilité rachidienne, aux exercices respiratoires ou de posture, pourtant classiquement centraux dans la prise en charge de l'axSpA — confirmé sur les deux références, ce n'est pas un accès bloqué mais un vide de contenu constaté.

Intensité — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : chez les personnes déconditionnées ou avec limitations fonctionnelles importantes, l'exercice à intensité modérée ou vigoureuse peut être initialement trop épuisant. Il est jugé approprié de débiter avec une dose plus faible, bien tolérée, puis d'augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. Au-delà de ce principe, les paramètres FITT-VP exacts (fréquence, intensité, temps, type, volume, progression) doivent être définis individuellement par le professionnel de santé (Recommandation 7 du document) — aucun chiffre cible générique (ex. % FC max, minutes/semaine) n'est fourni par cette référence.

Progression — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : chez les personnes déconditionnées ou avec limitations fonctionnelles importantes, l'exercice à intensité modérée ou vigoureuse peut être initialement trop épuisant. Il est jugé approprié de débiter avec une dose plus faible, bien tolérée, puis d'augmenter progressivement la durée ou la charge sur les 4 à 6 premières semaines. Au-delà de ce principe, les paramètres FITT-VP exacts (fréquence, intensité, temps, type, volume, progression) doivent être définis individuellement par le professionnel de santé (Recommandation 7 du document) — aucun chiffre cible générique (ex. % FC max, minutes/semaine) n'est fourni par cette référence.

Contre-indications — D'après EULAR 2025/2026 (Rausch Osthoff et al., Ann Rheum Dis 2026;85:1026-1038 — texte intégral vérifié, section « Recommandation 4 ») : il n'existe pas de contre-indication spécifique à la pathologie pour l'activité physique en tant que telle chez les personnes avec arthrite inflammatoire ou arthrose (« there are no disease-specific contraindications for PA per se » — cette contre-indication figurait dans la version 2018 des recommandations EULAR mais a été retirée en 2025/2026, faute de preuve). En revanche, l'intensité doit être adaptée à l'activité de la maladie et à l'état de santé du moment : en cas d'atteinte d'une articulation donnée (ex. genou gonflé), éviter l'exercice de forte intensité impliquant spécifiquement cette zone ; l'exercice de forte intensité reste possible sur les zones non atteintes (ex. membres supérieurs à la place des membres inférieurs).

Précautions — D'après EULAR 2025/2026 (texte intégral) : les effets indésirables rapportés dans les études sur l'arthrite inflammatoire et l'arthrose sont transitoires et légers (ex. douleur musculaire, fatigue) ; aucun effet délétère de l'exercice sur l'activité de la maladie n'est rapporté. Une augmentation transitoire de la douleur dans les 48 à 72 heures suivant l'exercice peut être normale (courbatures/DOMS), en particulier chez les personnes novices en exercice. En cas de poussée, les activités de forte intensité peuvent devenir impossibles, mais des activités de plus faible intensité (marche, exercices d'amplitude articulaire) restent le plus souvent possibles — à adapter selon la zone du corps touchée. Complément ASAS-EULAR 2022 (texte intégral vérifié le 23/08/2026) : l'exercice supervisé (kinésithérapie) est rapporté plus efficace que l'exercice seul à domicile — à prendre en compte pour un usage en autonomie via cette application. Rappel : aucune adaptation spécifique à l'atteinte axiale/rachidienne n'a pu être vérifiée dans l'une ou l'autre référence (cf. detailed_description) — à valider impérativement avant tout usage clinique.

Critères d'arrêt — *PROPOSITION (hors des 10 références citées, repère générique d'exercice thérapeutique — à valider) — douleur rachidienne > 6/10, raideur empêchant la poursuite de l'exercice.*

Références (DOI) — 10.1016/j.ard.2026.03.006,10.1136/ard-2022-223296

Votre décision

Statut retenu (entourer ou écrire) : draft / pending_validation / validated / retiré

Modifications ou compléments à apporter avant validation :
